

QE!!

OTITES EXTERNES AIGUES

I. Introduction :

- Inflammation le plus souvent infectieuse (bactéries / mycoses) de l'oreille externe :

Conduit auditif externe : CAE

- Otite externe bactérienne : aigue
- Otomycose : subaigue
- Otite externe nécrosante : chronique

QE ++

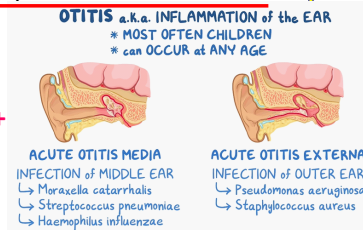
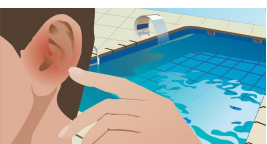
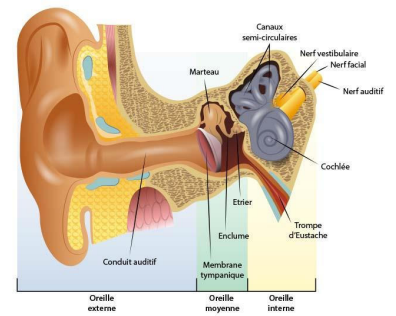
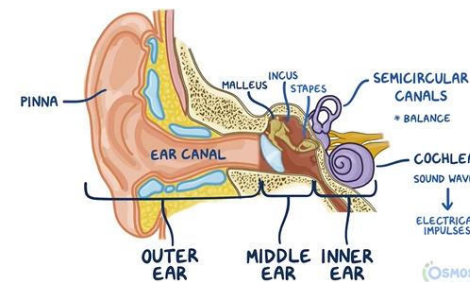
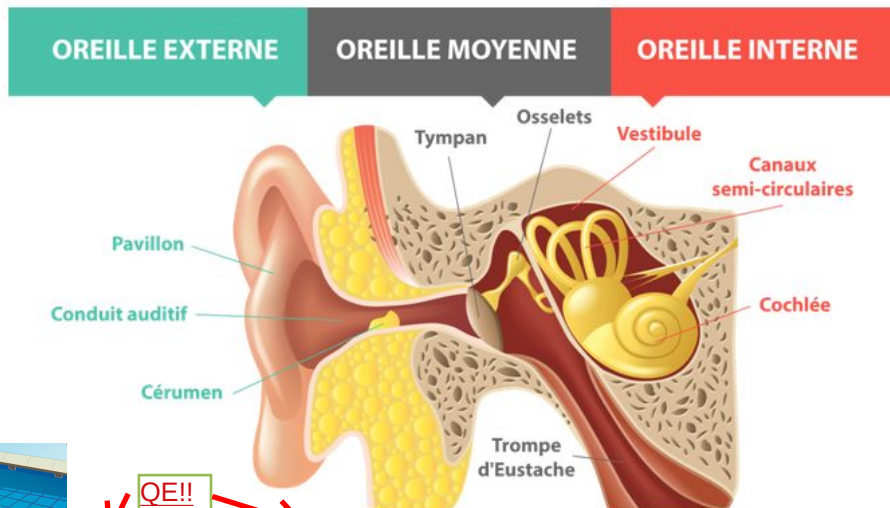


Figure 73.1 An individual with otitis externa of the left ear.

Pavillon :

- Chondrite aigue
- Chondrite chronique

II. Rappels anatomo-physiologiques



QE!!

Pathogénie

Agent pathogène

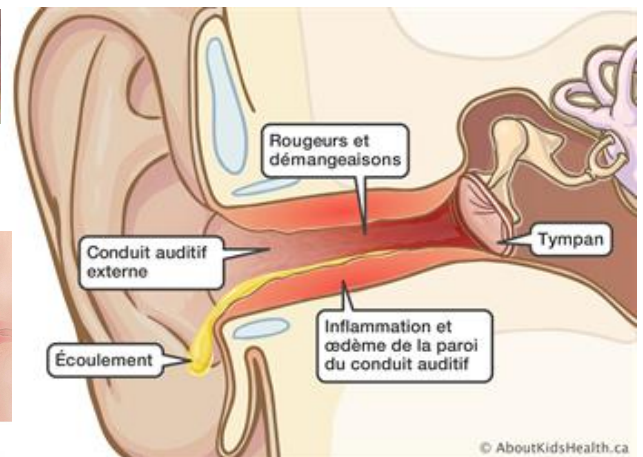
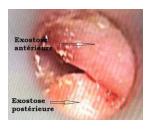
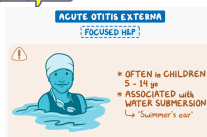
III. Epidémiologie :

- Très fréquente l'été +++

- F >> H

Facteurs favorisants :

- Eczéma du CAE / terrain atopique
- Humidité et macération
- Beignades
- Nettoyage fréquent de l'oreille



IV. Diagnostic positif : QE +++

Douleur : Otagies ++

- Spontanée
- Provoquée à la mastication, pression du tragus, mobilisation du pavillon

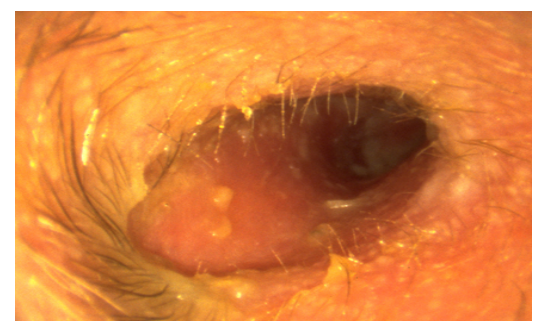
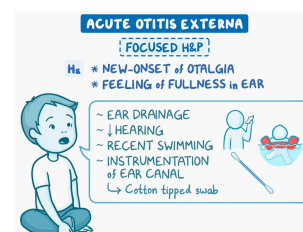
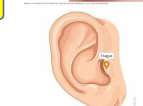
- Accentuée dans la 1^{ère} partie de la nuit

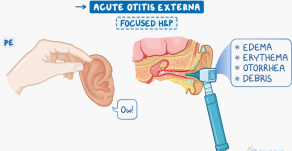
Fièvre : Formes aigues

Otorrhée : claire, purulente

Rougeur et œdème du CAE → Sténose CAE

QE!!





QE!!

A RETENIR

- **Diagnostic clinique** : douleur palpation tragus et traction du pavillon, conduit auditif externe (CAE) sténosé.
- **FDR** : micro-traumatisme (coton-tige) et humidification du CAE.
- **Se méfier chez patient diabétique** : risque otite externe maligne.

- **Tuméfaction du pavillon** : chondrite
- **Paralysie faciale** : Otite nécrosante

Diagnostic différentiel

Formes cliniques

V. Diagnostic étiologique :

1. Otite externe bactérienne aigüe :

- Otite du baigneur
- Staph
- Terrain immunocompétent
- ATCD de dermite atopique, eczéma du CAE
- Furoncle : Forme particulière, abcès du CAE

Traitement :

- Antibiothérapie locale
- ATG
- Méchage du CAE si sténose
- Antibiothérapie par voie orale : si échec ou furoncle ou sujet à risque → Pénim / Quinolones
- Drainage du furoncle ++

Otoscopie

2. Otite externe mycosique : Otomycose +++

- Prurit + otorrhée +/- douleur
- ATCD : Eczéma du CAE + utilisation fréquente du coton tige
- Mycoses : Aspergillus / candidose
- Terrain immunocompétent
- **Traitement :**

- Aspiration pour nettoyage du CAE
- Règles d'hygiène
- Antifongique local
- Antifongique par voie orale si sujet ID

3. Otite externe nécrosante : QEE ++

- Terrain ID : DAC, post-radiothérapie, VIH, patients sous immunodépresseurs
- Pseudomonas +++, staph, aureus
- Polype inflammatoire saignant du CAE
- Ostéite du tympanal → PF → Paralysie du X, IX, XI
- Exploration : TDM, IRM, NFS, CRP, glycémie, HbA1C, sérologies

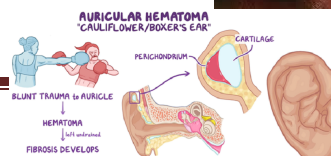
Traitement :

- Voie parentérale : plusieurs semaines (C3G + Quinolone)
- Voie orale : Plusieurs mois (fonction de la bactérie)
- Corticothérapie (10j) si PF associée
- ATG
- Aspiration CAE

Formes virales

4. Chondrite :

- Inflammation du cartilage du pavillon :
- Aigüe infectieuse : Souvent unilatérale (post-traumatique ou otite nécrosante)
- Chronique systémique : Souvent bilatérale (polychondrite atrophiante)
- Préjudice esthétique majeur → **Urgence thérapeutique +++ !**





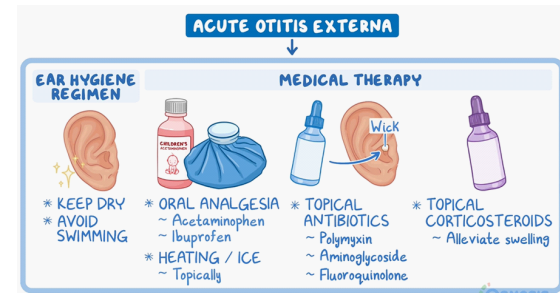
• Traitement :

- ATB ; Quinolones
- Drainage d'abcès ou d'hématome avec pansement compressive
- ATG
- Corticothérapie : Formes chroniques systémiques



VI. Conclusion

- ✓ Ne pas sous-estimer une otite externe chez un diabétique ou un ID
- ✓ Otites bénignes VS otites dangereuses : terrain immunocompétent ou ID
- ✓ Prévention ++++



QE : OTITE EXTERNE MALIGNE ET NECROSANTE

(Issu de l'ancien cours)

1. Otoscopie :

- Difficile car douleur
- CAE inflammatoire plus ou moins sténosé
- Tissu de granulation à la jonction os/cartilage
- Après aspiration : os et/ou cartilage peuvent être à nu, avec parfois des séquestres osseux : attention à la méningite et la paralysie des nerfs crâniens

2. TDM : confirme le diagnostic : Ostéolyse de la corticale osseuse de la mastoïde et du tympan (se comporte comme une tumeur maligne)

3. IRM : examen de choix pour préciser l'étendue vers les parties molles, la médullaire osseuse, les méninges et les nerfs crâniens (une OE avec paralysie des nerfs crâniens est une OEMN)

4. Scintigraphie osseuse : très fiable :

- Excellente sensibilité
- Moins bonne spécificité (même apparence que les tumeurs malignes)
- Hyperfixation précoce du MDP-Tc 99m sur l'os temporal (intérêt pour le diagnostic rapide)